IfSG & ÖGD

Unterricht für den ÖGD

Jakob Schumacher

2026-04-13

Inhaltsverzeichnis

1. Zielgruppe **1**
1.1. Die wichtigsten Punkte . . . 1
1.2. Limitationen . . . 1
1.3. Danksagungen . . . 1

I. Grundlagen **2**

2. Einordnung **3**
2.1. Gesetzesbeziehung . . . 3
2.2. Das IfSG ist zentral im Infektionsschutz . . . 3
2.3. Das IfSG ist Teil des Ordnungsrechtes . . . 4
2.3.1. Aufgaben des Infektionsschutzes nach IfSG . . . 4

3. Prägung des IfSG **5**
3.1. Das IfSG (bzw. seine Vorläufergesetze) sind alt . . . 5
3.2. Metapher: Ständig weiterentwickelte Kaserne . . . 5
3.3. Einflussreiche Epidemien in Deutschland . . . 5
3.4. Änderungen im IfSG . . . 6
3.5. Unterschied HIV/TBC . . . 6

5. Bestimmende und Kosten **8**
5.1. Wer bestimmt über das Meldewesen? . . . 8
5.2. Wer bezahlt das Meldewesen? . . . 8

6. "Besondere Begriff" **9**
6.1. Meldebegriffe . . . 9
6.2. Einteilung betroffener Personen . . . 9
6.3. Einteilung von Krankheiten . . . 9

II. Einleitungsparagraphen **10**

7. § 1 Ziel und Rahmen **11**
7.1. Gesetzesauszug . . . 11
7.2. Bemerkenswerte Punkte . . . 11

8. § 3 Prävention durch Aufklärung **12**
8.1. Gesetzesauszug . . . 12
8.2. Bemerkenswerte Punkte . . . 12

9. § 4 Das Robert Koch-Institut **13**
9.1. Gesetzesauszug . . . 13
9.2. Bemerkenswerte Punkte . . . 13

III. Meldewesen 14

11. § 6 Die Arztmeldepflicht 16
11.1. Gesetzesauszug . . . 16
11.2. Bemerkenswerte Punkte . . . 16

12. § 7 Die Labormeldepflicht 17
12.1. Gesetzesauszug . . . 17
12.2. Bemerkenswerte Punkte . . . 17

13. § 8 Meldepflichtige 18

14. § 9 Namentliche Meldung 19
14.1. Gesetzesauszug . . . 19
14.2. Bemerkenswerte Punkte . . . 19

15. § 11 Übermittlung 20
15.1. Gesetzesauszug . . . 20
15.2. Bemerkenswerte Punkte . . . 20

16. § 12 Der Notfallparagraph 21
16.1. Gesetzesauszug . . . 21
16.2. Bemerkenswerte Punkte . . . 21
16.3. Beispiel . . . 21
16.4. Beispielproblem . . . 21
16.5. Herangehensweise . . . 21

IV. Verhütung 23

17. § 16 Der Wir-dürfen-alles-Paragraph 24
17.1. Gesetzesauszug . . . 24
17.2. Bemerkenswerte Punkte . . . 24
17.3. Beispiel . . . 24
17.4. Beispielproblem . . . 24
17.5. Herangehensweise . . . 24

18. § 20 Der Impfparagraph 25
18.1. Gesetzesauszug . . . 25
18.2. Bemerkenswerte Punkte . . . 25

19. § 23 Hygieneparagraph 26
19.1. Gesetzesauszug . . . 26
19.2. Bemerkenswerte Punkte . . . 26
19.3. Beispiel . . . 26
19.4. Beispielproblem . . . 26
19.5. Herangehensweise . . . 26

20. § 23a Impfstatus 27
20.1. Gesetzesauszug . . . 27
20.2. Bemerkenswerte Punkte . . . 27

V. Bekämpfung 28

21. § 25 Ermittlungen 29
21.1. Gesetzesauszug . . . 29
21.2. Bemerkenswerte Punkte . . . 29
21.3. Beispiel . . . 29
21.4. Beispielproblem . . . 29
21.5. Herangehensweise . . . 29

22. § 28 Das Schwert des Gesundheitsamtes 30
22.1. Gesetzesauszug . . . 30
22.2. Bemerkenswerte Punkte . . . 30
22.3. Beispiel . . . 30
22.4. Beispielproblem . . . 30
22.5. Herangehensweise . . . 30

VI. Einrichtungen 31

23. § 34 Kindereinrichtungen 32
23.1. Gesetzesauszug . . . 32
23.2. Bemerkenswerte Punkte . . . 32
23.3. Beispiel . . . 32
23.4. Beispielproblem . . . 32
23.5. Was haben wir getan? . . . 32

24. § 35 Pflegeheime 33
24.1. Gesetzesauszug . . . 33
24.2. Bemerkenswerte Punkte . . . 33

25. § 36 Massenunterkünfte 34
25.1. Gesetzesauszug . . . 34
25.2. Bemerkenswerte Punkte . . . 34

26. § 73 Ordnungswidrigkeiten 35
26.1. Gesetzesauszug . . . 35
26.2. Bemerkenswerte Punkte . . . 35
26.3. Beispiel . . . 35
26.4. Beispielproblem . . . 35
26.5. Herangehensweise . . . 35

VII. Die Flughafenübung 36

27. Die Flughafenübung 37

28. Die Meldewesenübung 38

VIII Diskussion 39

29. Wieso sind unsere Schreiben so unverständlich 40

30. Wiese betreiben wir so wenig Prävention? 42

31. Wieso aktzeptieren wir die schlechte Meldemoral von Ärzt*innen? 43

1. Zielgruppe

Das Infektionsschutzgesetz ist das zentrale Werkzeug im Infektionsschutz des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Dieses Mini-Lehrbuch bietet einen praxisnahen Einstieg in die wichtigsten Paragraphen und zeigt, wie das IfSG im Gesundheitsamt konkret angewendet wird. Das Mini-Lehrbuch ist primär für die Schulung im Weiterbildungskurs gedacht. Dabei liegt der Schwerpunkt auf die praktische Arbeit: Wann darf das Gesundheitsamt was?

Aus dem Inhalt:

- Grundlagen: Einordnung des IfSG ins deutsche Rechtssystem und seine historische Prägung
- Meldewesen: Arzt- und Labormeldepflicht, Surveillance-Systeme und der Weg der Daten Verhütung und Bekämpfung
- Praxisbeispiele: Konkrete Fallsituationen mit Lösungsansätzen – vom Ebola-Verdacht bis zum Shigellose-Ausbruch
- Übungen zum eigenen Verständnis
- Ärztinnen und Ärzte im Weiterbildungskurs zum Facharzt öffentliches Gesundheitswesen

1.1. Die wichtigsten Punkte

- Aufgabe: Infektionskrankheiten verhindern
- Der wichtigste Teil des Gesundheitsamtes steckt in den Köpfen unserer Partner.
- Wir müssen den Infektionsnotfall üben
- Wir dürfen (fast) alles nach § 16
- Wir müssen - und dürfen auch - nach § 25 ermitteln
- Das Meldewesen existiert damit wir Maßnahmen ergreifen
- Zusammenarbeit schlägt Meldepflicht (außer im Schadensfall)

1.2. Limitationen

Hier werden Sichtweisen von Jakob Schumacher dargestellt. Es gibt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Das IfSG verändert sich schnell und die Webseite kann also leicht veralten. Außerdem stellt dies die praktische Sicht auf das IfSG dar. Der Autor ist kein Jurist. Also: Benutzung auf eigene Gefahr.

1.3. Danksagungen

- Den Ausbidlungsprogrammen PAE und WBK
- Posit (für die Software RStudio und Quarto)
- Github (für das Hosting)
- Wikipedia (für die Bilder)

Teil I.

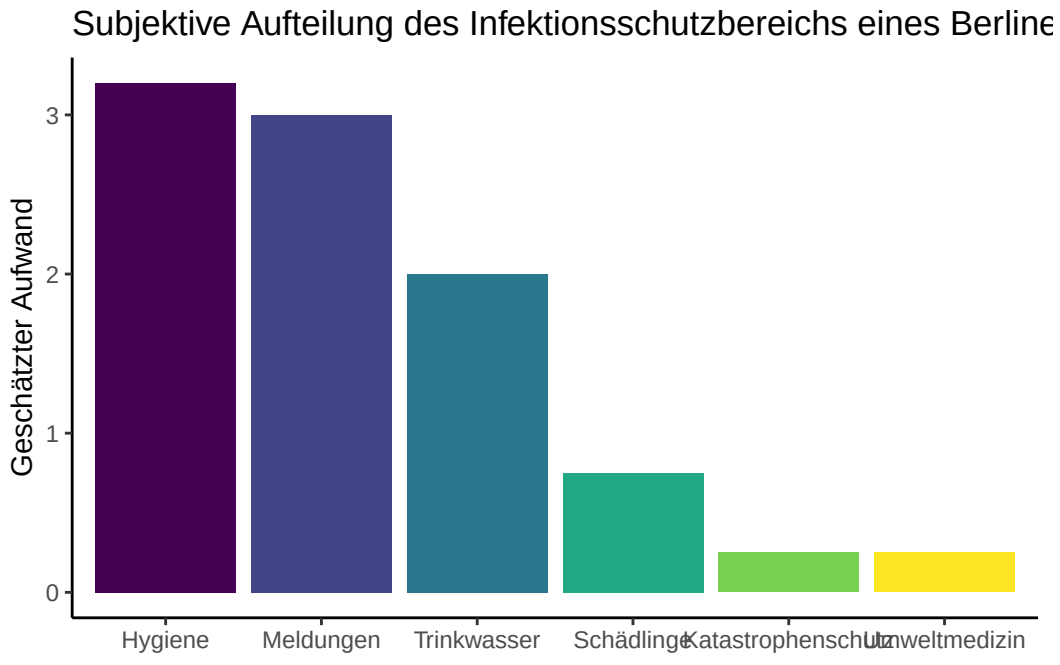
Grundlagen

2. Einordnung

2.1. Gesetzesbeziehung

- Das IfSG "entspringt" dem Grundgesetz Art. 74 Abs. 1 Nr. 19
- Es ist teil der konkurrierenden Gesetzgebung
- Die Länder sind für den Vollzug verantwortlich
- Aus dem IfSG entspringen eine ganze Reihe von Verordnungen, z.B.
  - Trinkwasserverordnung
  - Hygieneverordnung
  - Krankenhausverordnungen
  - Infektionsverordnung
  - Schädlingsverordnung

2.2. Das IfSG ist zentral im Infektionsschutz



2.3. Das IfSG ist Teil des Ordnungsrechtes

Das Ordnungsrecht kann man verstehen wie ein die Arbeit eines Linienrichters im Fußball: Aufgaben (Abseitserkennung, Ball-Aus-Erkennung); Eigene Regeln (Darf das Spielfeld nicht betreten, Unabhängigkeitsgrundsatz); Maßnahmen (Fahne heben und Tor für ungültig erklären); Bestrafungen (Gelbe Karte, Rote Karte)

2.3.1. Aufgaben des Infektionsschutzes nach IfSG

- Aufgaben
  - Gefahrenabwehr
- Eigene Regeln (Beispiele)
  - Gesetzesvorbehalt
  - Handlungsverpflichtung (Gebunden, Soll, Ermessen)
  - Übermaßverbot (Geeignetheit, Erforderlichkeit, Verhältnismäßigkeit)
  - Gleichheitsgrundsatz
- Maßnahmen (Beispiele)
  - Anweisung
  - Schließung
  - Teilnahme/Tätigkeitsverbote
  - Quarantäne
- Bestrafungen (Beispiele)
  - Ermahnung
  - Ordnungswidrigkeit
  - Zwangsgeld
  - Ersatzvornahme
  - Strafverfahren

3. Prägung des IfSG

3.1. Das IfSG (bzw. seine Vorläufergesetze) sind alt

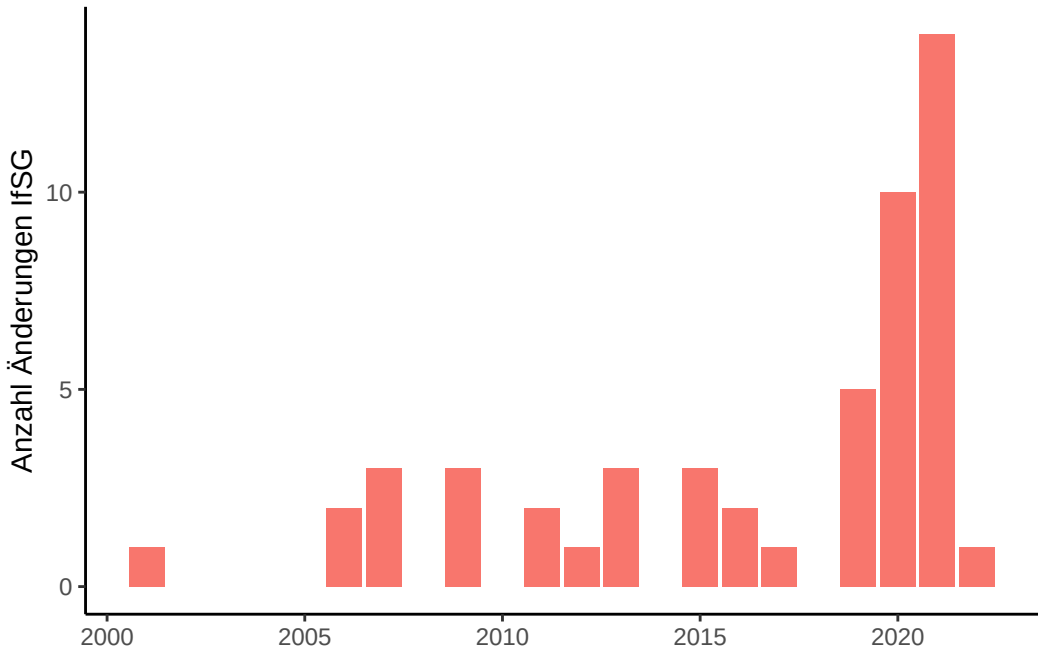
- Reichsseuchengesetz 1900
- Bundesseuchengesetz 1961
- Infektionsschutzgesetz 2000

3.2. Metapher: Ständig weiterentwickelte Kaserne

3.3. Einflussreiche Epidemien in Deutschland

- Tuberkulose, Cholera, Pest = Seuchengesetz insgesamt §16, §28-31
- HIV = Fokus auf Beratung
- Resistente Erreger = §23
- EHEC = Beschleunigung der Meldung/DEMIS §14
- SARS-CoV-2 = Bevölkerungsmaßnahmen §28a

3.4. Änderungen im IfSG



3.5. Unterschied HIV/TBC

- Tuberkulose: Untersuchungspflicht, Meldepflicht, Ermittlung, Kontaktpersonennachverfolgung, "Infektionsgefängnis"
- HIV: Beratung, anonyme Meldepflicht

4.

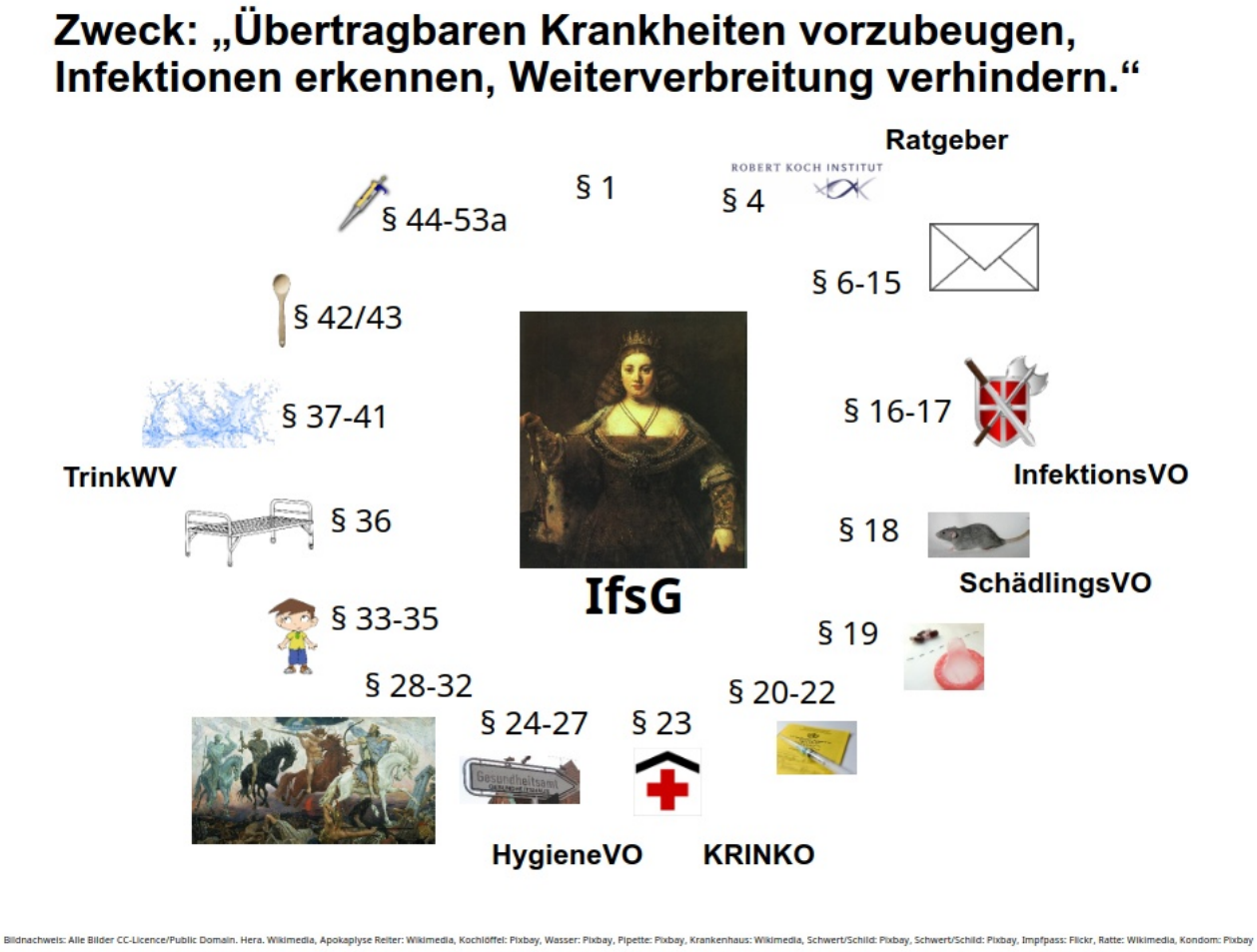


Abbildung 4.1.: Überblick über das IfSG

5. Bestimmende und Kosten

5.1. Wer bestimmt über das Meldewesen?

- Die fachliche Vorbereitung erfolgt am Robert Koch-Institut
- Das Infektionsschutzgesetz wird formuliert im Bundesministerium
- Viele Einrichtungen dürfen ihre Meinung abgeben z.B. BVÖGD
- Die Landesministerien entscheiden mit

5.2. Wer bezahlt das Meldewesen?

- Üblicherweise durch Einkünfte der Kommunen/Bundesland
- Kosten entstehen hauptsächlich durch das beteiligte Personal
- Meine Schätzung für die Gesamtkosten: 500.000 Fälle mal 80 Euro = 40 Mio. Euro

6. “Besondere Begriff”

6.1. Meldebegriffe

- **Meldung**: vom Meldepflichtigen an das Gesundheitsamt
- **Benachrichtigung**: Von Gemeinschaftseinrichtungen an das Gesundheitsamt
- **Übermittlung**: vom Gesundheitsamt an die Landesstelle
- **Unterrichtung**: vom Gesundheitsamt an ein anderes Amt

6.2. Einteilung betroffener Personen

- **Kranker**: Jemand mit Nachweis
- **Krankheitsverdächtiger**: Jemand mit Symptomen
- **Ausscheider**: Asymptomatisch
- **Ansteckungsverdächtiger**: Kontaktperson

6.3. Einteilung von Krankheiten

- **übertragbar**: Krankheit durch ein “Agens”

- **bedrohlich**: bedeutet eine schwerwiegende Gefahr

Teil II.

Einleitungsparagraphen

7. § 1 Ziel und Rahmen

Hier geht es zum § 1

7.1. Gesetzesauszug

> Zweck des Gesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten beim Menschen **vorzubeugen**, Infektionen frühzeitig zu **erkennen** und ihre **Weiterverbreitung zu verhindern**.
>
> Die hierfür notwendige Mitwirkung und Zusammenarbeit [...] soll entsprechend dem jeweiligen **Stand der medizinischen und epidemiologischen Wissenschaft und Technik gestaltet und unterstützt werden**.
>
> Die **Eigenverantwortung** der Träger und Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen, Lebensmittelbetrieben, Gesundheitseinrichtungen sowie des Einzelnen [...] soll verdeutlicht und gefördert werden.

7.2. Bemerkenswerte Punkte

- Artikel 1 hilft einem weiter in Zweifelsfällen: Wenn man vor einer Frage steht, wie man agieren soll, findet man hier die Richtung.
- Die Mitwirkung und Zusammenarbeit auf dem Stand der Technik ist ein hehres Ziel. Gut verwendbar für "Sonntagsreden"
- Hinter dem Fokus auf die **Eigenverantwortung** steht ein Konzept. Meine Umschreibung: *Der wichtigste Teil des Gesundheitsamtes steckt in den Köpfen unserer Partner*

8. § 3 Prävention durch Aufklärung

Hier geht es zum § 3

8.1. Gesetzesauszug

> Die **Information und Aufklärung** der Allgemeinheit über die Gefahren übertragbarer Krankheiten und die Möglichkeiten zu deren Verhütung sind eine öffentliche Aufgabe.

8.2. Bemerkenswerte Punkte

- Hinter *Prävention durch Information und Aufklärung* steckt ein Gesundheitskonzept, dass meiner Einschätzung nach einer Überarbeitung bedürfte. Wenn das mehr interessiert sei das Thema "Psychologie des Gesundheitsverhaltens" ans Herz gelegt. Zum Beispiel in diesem Buch zum Thema.

9. § 4 Das Robert Koch-Institut

Hier geht es zum § 4

9.1. Gesetzesauszug

(1) Das Robert Koch-Institut ist die nationale Behörde zur Vorbeugung übertragbarer Krankheiten sowie zur frühzeitigen Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen. Dies schließt die [...] Forschung [...] ein.

(2) Das Robert Koch-Institut erstellt im Benehmen mit den jeweils zuständigen Bundesbehörden **für Fachkreise** [...], **Empfehlungen**, Merkblätter und sonstige Informationen

(3) Das Robert Koch-Institut arbeitet zu den in § 1 Absatz 1 genannten Zwecken mit ausländischen Stellen und supranationalen Organisationen sowie mit der Weltgesundheitsorganisation und anderen internationalen Organisationen zusammen.

9.2. Bemerkenswerte Punkte

- Im § 4 wird das Robert Koch-Institut verankert.
- Das RKI ist "Ressortforschungseinrichtung" -> Das erlaubt Forschung und Wissenschaftsfreiheit
- Das RKI arbeitet (fachlich) mit den anderen Bundesoberbehörden zusammen (und nicht mit dem BMG)
- **Obersten** Landesgesundheitsbehörde können Amtshilfe beantragen
- Arbeit **für Fachkreise**
- Das RKI arbeitet auch international

Teil III.

Meldewesen

10.

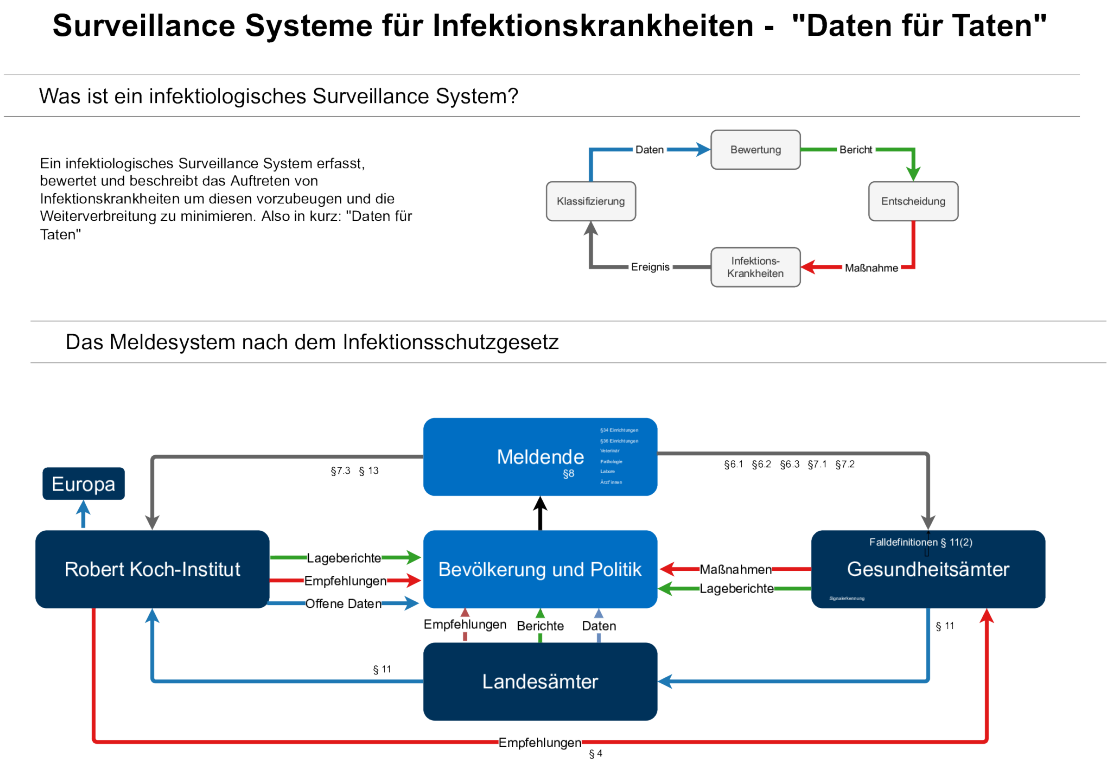


Abbildung 10.1.: Schaubild des deutschen Meldewesens

11. § 6 Die Arztmeldepflicht

Hier geht es zum § 6

11.1. Gesetzesauszug

> Namentlich ist zu melden: der Verdacht einer Erkrankung, die Erkrankung sowie der Tod
>
> Die Erkrankung und der Tod in Bezug auf folgende Krankheiten: behandlungsbedürftige Tuberkulose [...], Clostridioides-difficile-Infektion mit klinisch schwerem Verlauf
>
> Der Verdacht auf und die Erkrankung an einer mikrobiell bedingten Lebensmittelvergiftung
>
> Der Verdacht einer [UAW bei Impfungen]
>
> Die Verletzung eines Menschen durch [...] Tollwut
>
> Der Verdacht einer Erkrankung, die Erkrankung sowie der Tod, in Bezug auf eine bedrohliche übertragbare Krankheit, die nicht bereits nach den Nummern 1 bis 4 meldepflichtig ist.

11.2. Bemerkenswerte Punkte

- Hier gibt es die verschiedenen Meldetatbestände
  - *Verdacht, Krankheit, Tod* von bestimmten Krankheiten
  - Lebensmittelvergiftung
  - Impfnebenwirkung
  - Sonstige bedrohliche Krankheit
  - Nosokomiale Krankheiten
- Besonderheiten bei bestimmten Krankheiten
  - Nur bestimmte Clostridioides-Fälle
  - SSPE
  - Tuberkulose-Verweigerung
  - Tollwut auch bei Berührung
- Covid-19 ist auch bei Verdacht meldepflichtig -> Fachlich nicht sinnvoll
- Nichtnamentliche Meldepflicht bei Ausbrüchen -> Verursacht gewaltige Komplexitäten

12. § 7 Die Labormeldepflicht

Hier geht es zum § 7

12.1. Gesetzesauszug

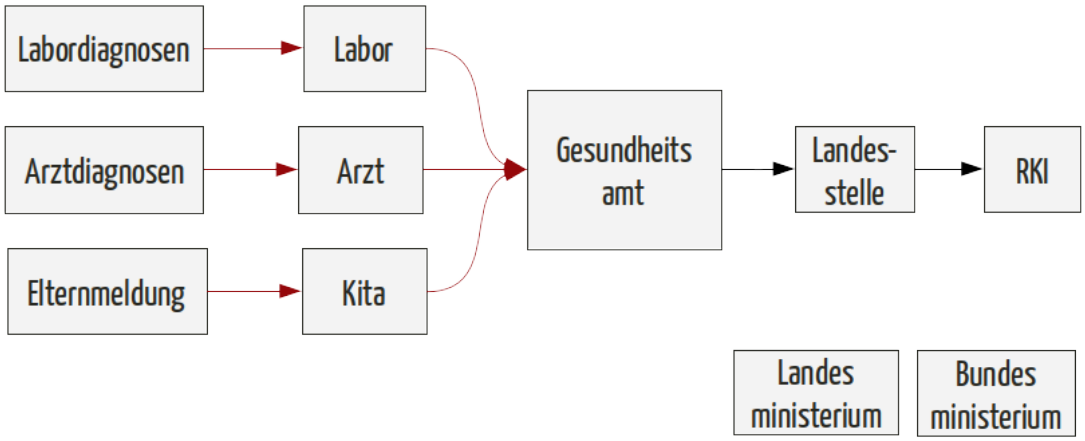
> Namentlich ist bei folgenden Krankheitserregern [...] der direkte oder indirekte Nachweis zu melden, soweit die Nachweise auf eine akute Infektion hinweisen
>
> Namentlich sind in Bezug auf Infektionen und Kolonisationen Nachweise [...] zu melden, wenn [...] Hinweise auf eine schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit bestehen.
>
> Nichtnamentlich ist bei folgenden Krankheitserregern der direkte oder indirekte Nachweis zu melden: [...] HIV

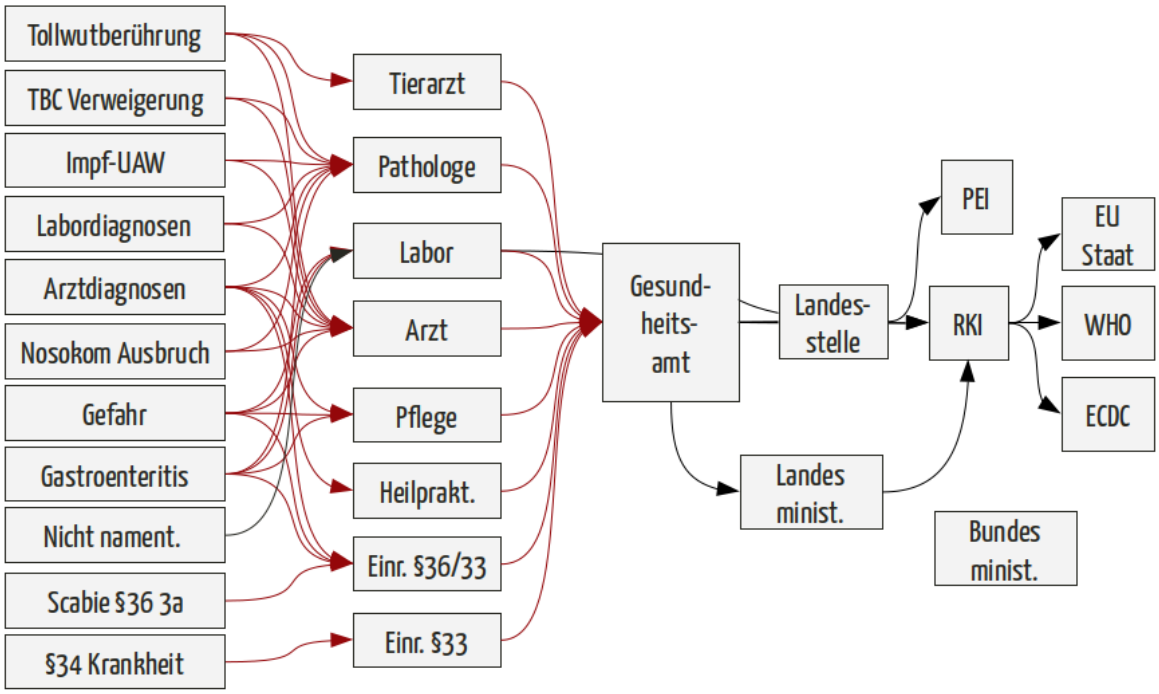
12.2. Bemerkenswerte Punkte

- Das ist das "Arbeitspferd" des Meldewesens
- Meldung bei *akuter* Infektion
- Auch Meldung für unbekannte Infektionen
- Nichnamentliche Meldung für HIV ist hier hinterlegt
- Meldung von *negativen* Tests für SARS-CoV-2

13. § 8 Meldepflichtige

Hier geht es zum § 8





14. § 9 Namentliche Meldung

Hier geht es zum § 9

14.1. Gesetzesauszug

(3) Die namentliche Meldung muss unverzüglich erfolgen und dem zuständigen Gesundheitsamt nach Absatz 4 spätestens 24 Stunden, nachdem der Meldende Kenntnis erlangt hat, vorliegen.

(4) Meldungen nach den Absätzen 1 und 2 haben an das Gesundheitsamt zu erfolgen, in dessen Bezirk sich die betroffene Person derzeitig aufhält oder zuletzt aufhielt. Sofern die betroffene Person in einer Einrichtung gemäß Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe h betreut oder untergebracht ist, haben Meldungen nach Absatz 1 an das Gesundheitsamt zu erfolgen, in dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet.

14.2. Bemerkenswerte Punkte

- Fehlerhafte Meldungen sind "messbar" im Gegensatz zu machen anderen Verstößen
- Klärung welche Gesundheitsamt die Meldung bekommt
- Klärung zuständiges Gesundheitsamt für Erfassung: *Gewöhnlicher Aufenthaltsort* (siehe auch §11)
- Übergabe an Bundeswehr

15. § 11 Übermittlung

Hier geht es zum § 11

15.1. Gesetzesauszug

(1) Die verarbeiteten Daten werden [...] anhand der Falldefinitionen [...] bewertet und spätestens am folgenden Arbeitstag [...] der zuständigen Landesbehörde [...] übermittelt:

15.2. Bemerkenswerte Punkte

- Zeitliche Vorgabe für Gesundheitsämter
- Klärung zuständiges Gesundheitsamt für Übermittlung: *Gewöhnlicher Aufenthaltsort*
- Klärung Übermittlungskette für Impfnebenwirkung

16. § 12 Der Notfallparagraph

§ 12

16.1. Gesetzesauszug

> Im Hinblick auf eine übertragbare Krankheit [nach IGV] übermittelt die zuständige Behörde der zuständigen Landesbehörde unverzüglich folgende Angaben:
>
> 1.das Auftreten der übertragbaren Krankheit, Tatsachen, die auf das Auftreten der übertragbaren Krankheit hinweisen, oder Tatsachen, die zum Auftreten der übertragbaren Krankheit führen können, 2. die getroffenen Maßnahmen und 3. sonstige Informationen, die für die Bewertung der Tatsachen und für die Verhütung und Bekämpfung der übertragbaren Krankheit von Bedeutung sind.

16.2. Bemerkenswerte Punkte

- Der Paragraph 12 ist der Notfall-Paragraph. Er basiert auf den Internationalen Gesundheitsvorschriften
- Um das zuverlässig zu gewährleisten sind **vorbeugende** Anstrenungen im Gesundheitsamt notwendig. Deswegen müssen Notfälle geübt werden.
- Er ist Teil der Event-Basierten-Surveillance
- Dieser Artikel ist hilfreich für Begründungen gegenüber der Politik

16.3. Beispiel

16.4. Beispielproblem

Feuerwehrleitzentrale ruft an: *"Notarzt vermutet Ebola-Fall"*

16.5. Herangehensweise

- Telefonisch §12 Meldung
- STAKOB Einrichtung anrufen
- Vor Ort gehen: Taxi/Feuerwehr/Polizei
- Material mitnehmen
- Information Mitarbeitende/Kommune
- Vor Ort: Anweisungen geben
  - Lagebesprechung
  - Patientenversorung mit PSA
  - Sperrbereich
  - KPs festlegen

- Desinfektion festlegen

Teil IV.

Verhütung

17. § 16 Der Wir-dürfen-alles-Paragraph

Hier geht es zum § 16

17.1. Gesetzesauszug

> Werden Tatsachen festgestellt, die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit führen können, oder ist anzunehmen, dass solche Tatsachen vorliegen, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zur Abwendung der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit hierdurch drohenden Gefahren.

17.2. Bemerkenswerte Punkte

- Dieser Artikel ist unglaublich breit. Deswegen: **Wir dürfen (fast) alles nach § 16**. Warum nur fast? Die Maßnahme muss geeignet, erforderlich und angemessen sein.

17.3. Beispiel

17.4. Beispielproblem

Bei einer Praxisbegehung: Der Arzt verwendet rostiges Werkzeug, hat falsches abgelaufenes Händedesinfektionsmittel, geflickte Desinfektionsanlage. Als der Arzt merkt, dass es kritisch wird, beruft er sich aufs Hausrecht und den Datenschutz und will alles schriftlich.

17.5. Herangehensweise

- Mündlich ausgesprochen: *Ich schließe jetzt ihre Praxis gemäß § 16 IfSG.*
- Kriterien für die Aufhebung der Schließung darstellen. CAVE: Einhaltung von Richtlinien als Ziel
- Auf Begehung und Unterlagen bestanden. Zur Not Polzei rufen.
- Ausführliches Protokoll erstellt, Photos mit Diensthandy gemacht
- Anordnung § 16 erstellt
- Rücksprache mit Rechtsamt

18. § 20 Der Impfparagraph

Hier geht es zum § 20

18.1. Gesetzesauszug

(1) Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die obersten Landesgesundheitsbehörden und die von ihnen beauftragten Stellen sowie die Gesundheitsämter **informieren** die Bevölkerung zielgruppenspezifisch über die Bedeutung von Schutzimpfungen
(2) Beim Robert Koch-Institut wird eine Ständige Impfkommission eingerichtet. [...] Die Mitglieder der Kommission werden vom Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen mit den obersten Landesgesundheitsbehörden berufen.
(3) Zur Durchführung von Schutzimpfungen ist jeder Arzt berechtigt. Siehe auch § 20c
(4) Folgende Personen [...] müssen entweder einen [...] ausreichenden Impfschutz gegen Masern [...] aufweisen

18.2. Bemerkenswerte Punkte

- STIKO ist hier verankert
- Hier ist erneut der Grundsatz: **Prävention durch Information**
- Faktischer Impfzwang für Kita/Schule und Berufe
- Diskrepanz zwischen genauer Festlegung hier und STIKO-Empfehlungen

19. § 23 Hygieneparagraph

Hier geht es zum § 23

19.1. Gesetzesauszug

> Die Leiter folgender Einrichtungen haben sicherzustellen, dass die nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um nosokomiale Infektionen zu verhüten und die Weiterverbreitung von Krankheitserregern [...] zu vermeiden:

19.2. Bemerkenswerte Punkte

- Hiermit kommen die KRINKO-Empfehlungen in die Welt
- Der **Stand der medizinischen Wissenschaft** ist ziemlich tiefgreifend und geht z.B. über den Stand von **Technik** hinaus.
- Die ART-Kommission wird hier gegründet
- Der Artikel hilft (bedingt) bei einer Begehung als Verpflichtung
- Gesundheitsämter sind selber auch betroffen in (3) Punkt 10
- Die Länder können und machen aufgrund dieses Paragraphen wichtig Rechtsverordnungen

19.3. Beispiel

19.4. Beispielproblem

Ein Krankenhaus hat nicht genügend Hygienepersonal.

19.5. Herangehensweise

- Ansprechen bei der Begehung
- Anordnung der Erfassung des nach KRINKO notwendigen Personals
- Einfacher durchzusetzen wäre die Hygieneverordnung

20. § 23a Impfstatus

Hier geht es zum § 23a

20.1. Gesetzesauszug

> Der Arbeitgeber [darf] personenbezogene Daten eines Beschäftigten über dessen Impf- und Serostatus verarbeiten.

20.2. Bemerkenswerte Punkte

- Gilt auch für Gesundheitsämter

Teil V.

Bekämpfung

21. § 25 Ermittlungen

Hier geht es zum § 25

21.1. Gesetzesauszug

> Ergibt sich oder ist anzunehmen, dass jemand krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder Ausscheider ist […] so stellt das Gesundheitsamt die erforderlichen Ermittlungen an

21.2. Bemerkenswerte Punkte

- Dieser Paragraph verpflichtet uns zur Ermittlung
- Es sind uns auch alle Berechtigungen gegeben.

21.3. Beispiel

21.4. Beispielproblem

Bei einem Infektionsschutzgespräch verweigert eine Person die Aussage.

21.5. Herangehensweise

- Bei weniger wichtigen Erkrankungen ignorieren
- Bei wichtigen Erkrankungen hinfahren (bsp. Masern)
- Versuch Infos woanders zu holen, z.B. bei Ärzt*innen
- Zwang wäre möglich

22. § 28 Das Schwert des Gesundheitsamtes

Hier geht es zum § 28

22.1. Gesetzesauszug

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt [...] so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen

22.2. Bemerkenswerte Punkte

- Dieser Paragraph ist in Verbindung mit den folgenden Paragraphen zu sehen, insbesondere 29, 30, 31.
- Zusammen ermöglichen diese Paragraphen quasi Gefängnisaufenthalte
- Wenn § 34 nicht aussreicht kann der § 31 verwendet werden.

22.3. Beispiel

22.4. Beispielproblem

Eine Labor meldet eine Person mit einer neuen Infektionskrankheit. Im selben Haushalt befindet sich noch ein weiterer asymptomatischer Fall, eine symptomatische Person ohne Labornachweis und eine Kontaktperson.

22.5. Herangehensweise

- Das Gesundheitsamt kann gegenüber allen Personen eine Maßnahme ansetzen.
- Möglich: Alle absondern
- Alternativ auch Berufsverbote
- Sinnvoll in Kombination mit Untersuchungen/Beobachtung

Teil VI.

Einrichtungen

23. § 34 Kindereinrichtungen

Hier geht es zum § 34

23.1. Gesetzesauszug

> Personen die an [*Auflistung mehrere Krankheiten*] erkrankt oder dessen verdächtig oder die verlaust sind, dürfen in den in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder sonstige Tätigkeiten ausüben

23.2. Bemerkenswerte Punkte

- Absatz ist wichtig für die Arbeit im Gesundheitsamt
- Es gibt eine Unterteilung nach Erkrankten, Ausscheidern und Mitbewohnende
- Gesetz gilt auch ohne Anordnung des Gesundheitsamtes
- Belehrungspflicht und Benachrichtigungspflicht
- Impfaufklärung (Einführung vor Impfpflicht)

23.3. Beispiel

23.4. Beispielproblem

Shigelloseausbruch Einer Hygienekontrolleurin fällt auf, dass sie heute zwei Shigellose-Fälle hat, die nicht aus dem Ausland kommen. Es stellt sich heraus, das es einige Fälle in einer Kita gibt.

23.5. Was haben wir getan?

- Vor Ort ermittelt
- VetLeb informiert
- Die Landesstelle gefragt, ob uns jemand unterstützen will
- Andere Kitas des Caterers Stuhlproben
- Kontaktdaten, Linelist
- Ausbruchsfalldefinition festgelegt
- TVs nach Wiederzulassungstabelle §34 angesetzt
- Aushang und Informationsweitergabe durch die Kitaleitung (FAQ durch uns)
- Anordnung Shigellenausbruch
- Keine Suche nach Personen mit riskantem Sexualverhalten

24. § 35 Pflegeheime

Hier geht es zum § 35

24.1. Gesetzesauszug

> Folgende Einrichtungen […] haben sicherzustellen, dass die nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft und der Pflegewissenschaft erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um Infektionen zu verhüten und die Weiterverbreitung von Krankheitserregern zu vermeiden 1. vollstationäre Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen (4) Einrichtungen haben das Gesundheitsamt […] zu benachrichtigen […] wenn eine in der Einrichtung tätige oder untergebrachte Person an Skabies erkrankt ist.

24.2. Bemerkenswerte Punkte

- Wichtiger Paragraph für Gesundheitsämter
- Skabies-Meldung
- Besondere COVID-19 Meldungen

25. § 36 Massenunterkünfte

Hier geht es zum § 36

25.1. Gesetzesauszug

> Folgende Einrichtungen und Unternehmen müssen in Hygieneplänen innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Infektionshygiene festlegen und unterliegen der infektionshygienischen Überwachung durch das Gesundheitsamt: * die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen mit Ausnahme[n] * Obdachlosenunterkünfte * [Asylunterkünfte] * sonstige Massenunterkünfte * Justizvollzugsanstalten
>
> Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt festzulegen, [..] dass Personen, die in […] Deutschland einreisen […] ein ärztliches Zeugnis […] vorzulegen haben

25.2. Bemerkenswerte Punkte

- Dieser Paragraph besagt, dass Gesundheitsämter bestimmte Einrichtungen begehen sollen und manche anderen können.
- Ebenfalls Skabies-Meldung
- Zwangsweise Tuberkulose-Meldung
- Einreisescreening. Bei Krisen wird gerne auf das “Ausland” verwiesen

26. § 73 Ordnungswidrigkeiten

Hier geht es zum § 73

26.1. Gesetzesauszug

> Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig [*Auflistung diverser Punkte*]

26.2. Bemerkenswerte Punkte

- In diesem § werden alle Ordnungswidrigkeiten aufgelistet
- Wenn jemand bei einer Ordnungswidrigkeit zu Schaden gekommen ist, sind Strafverfahren zu überlegen
- Was **nicht** hier erwähnt ist muss mit Zwangsgeld o.ä. durchgesetzt werden

26.3. Beispiel

26.4. Beispielproblem

Ein Krankenhaus vergisst eine Meldung von zwei Klebsiellen, die sich hinterher als der Beginn eines Ausbruches herausstellen.

26.5. Herangehensweise

- Gut überlegen wie man vorangeht, denn Kooperation wichtig
- Kann auch in eine Strafverfahren münden
- Definitiv Sache fürs Rechtsamt

Teil VII.

Die Flughafenübung

27. Die Flughafenübung

Kennst du das IfSG?

Hier geht es zur Flughafenübung

28. Die Meldewesenübung

Kennst du das IfSG?

Hier geht es zur Meldewesenübung

Bild-Quelle: Denis Apel http://www.denis-apel.de), CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.p

Teil VIII.

Diskussion

29. Wieso sind unsere Schreiben so unverständlich

Ergänzende Hinweise: Eine vorzeitige Entlassung aus der Quarantäne/Isolation ist für Sie bei vorheriger 48h Symptomfreiheit und für Ihre Kontaktpersonen nach Erhalt des negativen Testergebnisses in folgenden Konstellationen möglich:

- PCR-Testung frühestens am 7. Tag nach dem Zeitpunkt des Symptombeginns bzw. bei asymptomatischer Infektion ab dem Tag des PCR-Tests. (Tag des Symptombeginns oder PCR-Test + 7 Tage). Für Kontaktpersonen am 7. Tag nach dem Zeitpunkt des engen Kontakts (Tag des letzten engen Kontakts + 7 Tage).
- Zertifizierte PoC-Antigen Schnelltestung am 7. Tag nach dem Zeitpunkt des Symptombeginns bzw. bei asymptomatischer Infektion ab dem Tag des PCR-Tests. (Tag des Symptombeginns oder PCR-Test + 7 Tage). Für Kontaktpersonen am 7. Tag nach dem Zeitpunkt des engen Kontakts (Tag des letzten engen Kontakts + 7 Tage).
- **Nur für Kontaktpersonen gilt**: Für Schüler:innen, sowie Kinder in den Angeboten der Kinderbetreuung die regelmäßig im Rahmen einer seriellen Teststrategie getestet werden, kann der negative Nachweis auch mittels qualitativ hochwertigen Antigen-Schnelltests oder PCR-Testung am 5. Tag nach dem Zeitpunkt des engen Kontakts (Tag des letzten engen Kontakts + 5 Tage) erwogen werden. In diesem Fall ist eine tägliche Antigen-Testung bis Tag 10 nach Kontakt empfehlenswert.

Laut aktueller Test-Verordnung haben Sie hierfür Anspruch auf einen kostenfreien Antigen-Test (nach § 2 Abs. 1 der TestV) in einem Testzentrum. **Wir weisen Sie darauf hin, dass eventuell anfallende Kosten für eine Testung zur vorzeitigen Beendigung der Quarantäne/Isolation nicht vom Gesundheitsamt übernommen werden.**

Wird bereits vor dem 7. Tag eine Testung auf SARS-CoV-2 durchgeführt, so verkürzt ein negatives Testergebnis die Quarantäne/Isolationsdauer nicht.

Nach Erhalt des negativen Testergebnisses kann die Quarantäne beendet werden. Bitte senden Sie das negative Testergebnis an corona@ba-pankow.berlin.de Betreff: **Vorzeitige Entlassung aus der Quarantäne.**

Bitte beachten: Ihre engen Kontaktpersonen müssen sich ab dem letzten Kontakt zu Ihnen für 10 Tage absondern.

Ausgenommen von der Pflicht zur Quarantäne sind:

Personen mit einer Auffrischimpfung (Boosterimpfung), insgesamt drei Impfungen erforderlich (auch bei jeglicher Kombination mit COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)), **oder** Geimpfte Genesene (Einfach Geimpfte mit einer nachfolgenden Infektion oder Genesene, die eine Impfung im Anschluss an die Erkrankung erhalten haben) **oder** Personen mit einer zweimaligen Impfung, ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung bis zum 90. Tag nach der Impfung, gilt auch für COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) **oder** Genesene ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des positiven Tests

Dem Gesundheitsamt umgehend gemeldet werden müssen:

- Haushaltsmitglieder bzw. weitere enge Kontaktpersonen zu Ihnen für die die oben genannten Ausnahmen nicht gelten
- Haushaltsmitglieder mit Symptomen bzw. weitere enge Kontaktpersonen zu Ihnen mit Symptomen

Bitte melden sie im oben beschriebenen Fall Ihre Haushaltsmitglieder per Erhebungsbogen für Kontaktpersonen und bitten Ihre engen Kontaktpersonen außerhalb des Haushaltes sich ebenfalls per Erhebungsbogen zu melden. Diesen finden Sie auf folgender Webseite, bitte pro Person jeweils einmal ausfüllen: https://www.berlin.de/ba-pankow/kp/
Dadurch können wir diesen bei Bedarf zeitnah Informationen zukommen lassen und Absonderungsbescheide erstellen.

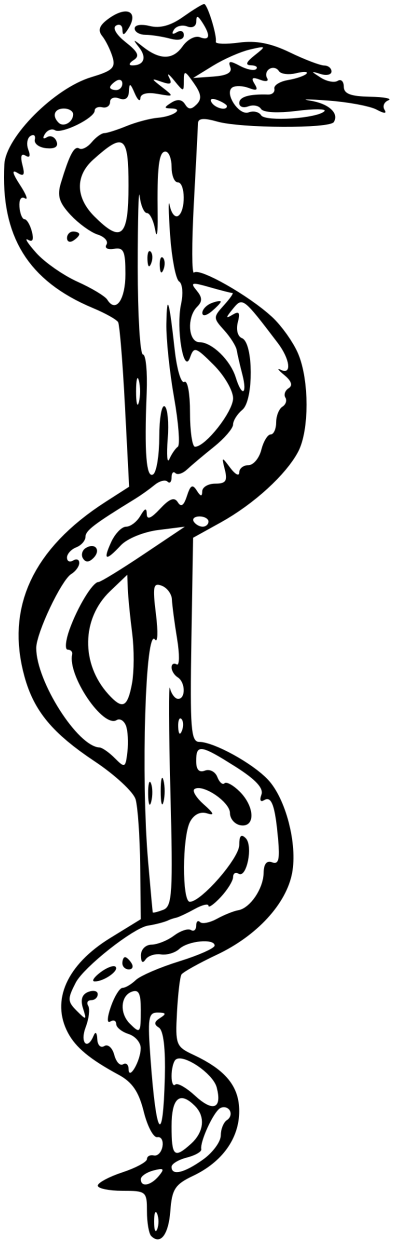
Symptomatische Kontaktpersonen gelten unabhängig von einer möglichen Ausnahme von der Quarantänepflicht als Verdachtspersonen und müssen sich ebenfalls bis zum Erhalt eines negativen PCR-Testergebnisses isolieren.

Für eine kostenfreie PCR-Testung als Kontaktperson in den landeseigenen Teststellen (zu finden unter **https://www.berlin.de/sen/gpg/service/oft-gesucht/artikel.1135347.php**) ist es ausreichend einen positiven Schnelltest vorzulegen. Alternativ erhalten Ihre Kontaktpersonen mit der Mitteilung des Gesundheitsamtes einen Ersatz-ÖGD-Schein. Es ist empfohlen den PCR-Test an Tag 3-5 nach dem letzten Kontakt mit der infizierten Person oder bei auftretenden Symptomen durchzuführen.

Als relevanter Zeitraum für eine Infektion gelten bereits die Tage 48 Stunden vor Ihrem Symptombeginn bzw. 48 Stunden vor Ihrem positiven Test, bei einer asymptomatischen Erkrankung. Als enge Kontaktpersonen gelten Personen in den folgenden Situationen:

- Aufenthalt im Nahfeld des Falls (<1,5 m) länger als 10 Minuten ohne durchgehend und korrekt getragenen Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske **oder** Gespräch mit dem Fall (Face-to-face-Kontakt, <1,5 m, unabhängig von der Gesprächsdauer) ohne durchgehend und korrekt getragenen Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske **oder** Aufenthalt von Kontaktperson (und Fall) im selben Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole unabhängig vom Abstand für länger als 10 Minuten, auch wenn durchgehend und korrekt Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske getragen wurde.

Genesenenzertifikat: Ein Genesenenzertifikat erhalten Sie 4 Wochen nach Testung kostenlos unter Vorlage des PCR-Laborbefundes und Ihres Ausweises in vielen Apotheken. Unter Ihrer PLZ und der Service-Leistung "Covid-19-Zertifikat" finden Sie so die nächstgelegene Apotheke unter www.mein-apothekenmanager.de

30. Wiese betreiben wir so wenig Prävention?

31. Wieso aktzeptieren wir die schlechte Meldemoral von Ärzt*innen?